Nama : Ninda Nurul Huda

NIM: 2507046

LAPORAN ANALISIS STAKEHOLDER & POWER–INTEREST GRID

Implementasi Sistem Informasi Terintegrasi pada Klinik Sehat Bersama

Profil Singkat Organisasi & Proyek

Nama Organisasi: Klinik Sehat Bersama

Bidang Usaha: Pelayanan kesehatan swasta (pemeriksaan umum, konsultasi dokter, tindakan medis, farmasi/obat).

Latar Belakang Proyek: Proses pelayanan masih manual dan menggunakan aplikasi terpisah sehingga kurang efisien, pencarian riwayat pasien lambat, serta pelaporan belum terpadu.

Tujuan Proyek: Mengembangkan Sistem Informasi Klinik Terintegrasi yang mencakup pendaftaran, rekam medis elektronik, peresepan & stok obat, kasir/pembayaran, hingga pelaporan eksekutif manajemen.

Analisis Stakeholder, Penilaian Power & Interest, dan Strategi Komunikasi

Skala penilaian (1–5) mengacu pada pedoman:

* Power (Kekuatan/Otoritas): 1 (Sangat Rendah) – 5 (Sangat Tinggi / Penentu Utama).

* Interest (Kepentingan/Ketergantungan): 1 (Sangat Rendah) – 5 (Sangat Peduli / Berdampak Langsung).

No	Stakeholder	Power (1–5)	Interest (1–5)	Analisis & Argumentasi Nilai	Strategi Komunikasi & Pengelolaan
1	Pemilik Klinik	5	4	Memiliki otoritas tertinggi atas bisnis dan pendanaan proyek (Power 5), serta berkepentingan pada efisiensi layanan dan pertumbuhan bisnis (Interest 4).	Manage Closely: Libatkan dalam persetujuan anggaran strategis, sampaikan laporan berkala terkait milestone dan proyeksi ROI/dampak bisnis.

No	Stakeholder	Power (1–5)	Interest (1–5)	Analisis & Argumentasi Nilai	Strategi Komunikasi & Pengelolaan
2	Kepala Klinik	5	5	Pemimpin langsung proyek pengembangan sekaligus pengambil keputusan operasional harian (Power 5) yang sangat bergantung pada sistem untuk laporan dan integrasi layanan (Interest 5).	Manage Closely: Koordinasi intensif, libatkan dalam seluruh evaluasi kemajuan mingguan, dan validasi fungsionalitas sistem.
3	Divisi IT	4	5	Bertanggung jawab penuh terhadap integrasi arsitektur, keamanan data medis pasien, dan pemeliharaan teknis (Power 4 & Interest 5).	Manage Closely: Rapat koordinasi harian/teknis (daily stand-up), pengawasan implementasi, serta audit kepatuhan keamanan data.
4	Dokter	3	5	Pengguna inti rekam medis dan peresepan; penolakan dokter bisa menghambat adopsi sistem (Power 3). Sangat butuh riwayat pasien yang cepat dan akurat (Interest 5).	Keep Informed: Sediakan sesi pelatihan intensif yang fleksibel, sediakan jalur pengaduan/masukan cepat, dan pendampingan transisi (hands-on).

No	Stakeholder	Power (1–5)	Interest (1–5)	Analisis & Argumentasi Nilai	Strategi Komunikasi & Pengelolaan
5	Perawat	2	4	Berperan mencatat tindakan dan tanda vital pasien; pengaruh operasional sedang (Power 2), tetapi sangat terdampak perubahan alur kerja dari manual ke sistem (Interest 4).	Keep Informed: Pelatihan berkala, pembuatan panduan visual ringkas (SOP/cheatsheet), dan forum diskusi penyesuaian alur kerja.
6	Petugas Pendaftaran	2	4	Berada di garda depan pelayanan pasien; pengaruh rendah terhadap arsitektur sistem (Power 2), namun sangat membutuhkan antarmuka yang cepat untuk mengurangi antrean (Interest 4).	Keep Informed: Simulasi pendaftaran pasien, pelatihan modul registrasi, dan pengumpulan umpan balik terkait kecepatan input.
7	Apoteker	3	4	Pengelola stok obat dan validasi resep; kesalahan data stok berisiko fatal pada operasional (Power 3). Sangat berkepentingan pada akurasi resep elektronik (Interest 4).	Keep Informed: Uji coba modul integrasi farmasi-resep dokter, pemantauan pencatatan stok, dan verifikasi alur mutasi obat.

No	Stakeholder	Power (1–5)	Interest (1–5)	Analisis & Argumentasi Nilai	Strategi Komunikasi & Pengelolaan
8	Petugas Kasir / Keuangan	3	4	Menangani arus transaksi dan laporan keuangan klinik (Power 3). Sangat peduli pada pencatatan pembayaran yang valid dan rekonsiliasi yang akurat (Interest 4).	Keep Informed: Uji coba penutupan kas harian (closing kasir), pelatihan pelaporan transaksi, dan transparansi integrasi tarif.
9	Vendor Pengembang	4	3	Memegang kendali atas kode/fitur teknis dan jadwal rilis (Power 4). Terikat kontrak banyak proyek lain sehingga fokusnya hanya sebatas lingkup kerja (Interest 3).	Keep Satisfied: Penegasan SLA (Service Level Agreement), pengawasan jadwal deliverable, serta pembayaran tepat waktu sesuai progres.
10	Pasien	1	3	Pengguna akhir layanan; tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan internal (Power 1), tetapi peduli terhadap kecepatan antrean dan keakuratan pelayanan (Interest 3).	Monitor: Menyediakan kotak saran/survei kepuasan digital pasca-implementasi, serta memasang informasi alur layanan baru di ruang tunggu.

Pengelompokan Berdasarkan Kuadran Power–Interest Grid

1. Manage Closely (High Power – High Interest)
    - Stakeholder: Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Divisi IT.
    - Karakteristik: Penentu kesuksesan proyek yang memiliki wewenang tinggi sekaligus kepentingan langsung. Harus dilibatkan secara intensif dalam seluruh keputusan strategis.
2. Keep Satisfied (High Power – Low/Moderate Interest)
    - Stakeholder: Vendor Pengembang Sistem.
    - Karakteristik: Memiliki kekuatan eksekusi teknis yang tinggi namun kepentingan institusional terbatas pada kontrak. Jaga hubungan kerja profesional, pastikan kepatuhan timeline dan klausul kontrak.
3. Keep Informed (Low/Moderate Power – High Interest)
    - Stakeholder: Dokter, Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Kasir/Bagian Keuangan.
    - Karakteristik: Pengguna operasional harian yang sangat terpengaruh oleh sistem baru tetapi memiliki otoritas terbatas. Perlu komunikasi rutin, edukasi, pelatihan, dan wadah untuk menampung kekhawatiran transisi.

4. Monitor with Minimum Effort (Low Power – Low Interest)

    - Stakeholder: Pasien.

    - Karakteristik: Tidak terlibat langsung dalam tata kelola internal; cukup dipantau tingkat kepuasan dan responsnya terhadap durasi antrean.